Ordonnance collective

Médications pour la prévention du paludisme et du mal des montagnes et pour le traitement de la diarrhée chez les voyageurs, de la cystite récidivante et des réactions anaphylactiques

Cliniques du Groupe santé voyage

En vigueur : 1er mars 2012

Dernière révision Juin 2024

Table des matières

A. Buts et cibles 3
Personnel visé 3
Groupes de clients visés 3
Transmission de l'ordonnance collective aux professionnels : 3
B. Protocole 3
Formulaire de liaison 4
Médecin répondant 4
C. Médications couvertes par cette ordonnance collective 5
C.1 Schémas prophylactiques contre le paludisme 5
C.1.1 Chloroquine 7
C.1.2 Atovaquone-proguanil. (ATQ-PG) 8
C.2 Traitement d'urgence de la diarrhée 10
C.2.1 Ciprofloxacine 10
C.2.2 Azithromycine (Zithromax 11
C.2.3 Céfixime (Suprax) 13

C.3 Traitement en voyage de la cystite récidivante non compliquée 14
Clientèle, catégories de clientèles ou situation clinique visée
Contre-indications / Limites
C.4 Prévention du mal aigu des montagnes (MAM) 15
C.4.1 Acétazolamide (Diamox)
C.5 Traitement d'urgence de l'anaphylaxie 17
C.5.1 Dose des auto-injecteurs 17
D. Rédaction du formulaire de liaison et vérifications 18
Identification des professionnels 18
Identification du patient 18
E. Tenue de dossiers 18
F. Communications avec les patients, les pharmaciens et les collègues: 18
G. Médecins signataires 18
H. Site d'hébergement du protocole de l'ordonnance collective 19
I. Documentation 19
J. Signataires 20
K. Annexes 20
Annexe 1 Médicaments utilisés pour la prévention du paludisme chez les adultes et les adolescents inclus dans ce protocole. 20
Annexe 2 Médicaments utilisés pour la prévention du paludisme chez les enfants inclus dans ce protocole. 22
Annexe 3 Formulaire de liaison: Adultes et adolescents 23
Annexe 4 Formulaire de liaison: Enfants voyageurs 24

Annexe 5 Contre-indications à la chloroquine
(Phosphate de CHLOROQUINE, Aralen) 25
Annexe 6 Contre-indications à l'association atovaquone-proguanil (Malarone) 26
Annexe 7 Contre-indications à la ciprofloxacine Ciprofloxacine (Cipro) 26
Annexe 8 Contre-indications à l'azithromycine (Zithromax) 28
Annexe 9 Contre-indications à l'acétazolamide (Diamox) 29
Annexe 10 Auteurs 29

Toute modification ou reproduction partielle ou complète est interdite sans l'autorisation des auteurs.

A. Buts et cibles

1- Procédures liées à la recommandation de médications visant à prévenir le paludisme.
2- Procédures visant à la recommandation d'une médication pour le traitement d'urgence de la diarrhée du voyageur.
3- Procédures visant à la prévention du mal des montagnes (formation spécifique requise).

Personnel visé

Infirmières travaillant aux cliniques du Groupe santé voyage qui ont reçu la formation des différentes sections.

Groupes de clients visés

Tout voyageur qui répond à toutes les caractéristiques suivantes :

- 1 mois ou plus en bonne santé en voyage pour 90 jours ou moins
- Voyage de moins de 90 jours
- Voyage touristique à une altitude la nuit de 4000 mètres ou moins
- Qui fera l'achat de sa médication au Québec
- Voyage touristique à une altitude la nuit de 4000 mètres ou moins
- Qui fera l'achat de sa médication au Québec

Transmission de l'ordonnance collective aux professionnels :

Pour que les pharmaciens puissent avoir accès au besoin au protocole en lien avec le formulaire de liaisons qui leur sera remis par les patients, une copie de l'ordonnance collective à jour sera disponible sur le site du Groupe Santé voyage.

L'adresse url pour accéder à ce document sera indiquée sur le formulaire de liaison. Tous les pharmaciens du Québec sont habilités par l'ordonnance collective d'un établissement ou d'une clinique.

B. Protocole

L'infirmière doit s'assurer qu'elle a la compétence requise, soit les connaissances, les habiletés et le jugement clinique en lien avec cette ordonnance collective. Elle doit avoir des connaissances suffisantes et spécifiques à la médication recommandée, incluant :

- Indications
- Effets secondaires
- Contre-indications
- Interactions médicamenteuses
- Doses et posologies recommandées
- Précautions à prendre
- Éléments à surveiller pendant ou après la prise du médicament
- Tout autre facteur qui pourrait être pertinent

Une infirmière doit toujours connaître les effets secondaires du médicament qu'elle recommande ou administre.

Formation spécifique obligatoire :
Les infirmières visées par cette ordonnance collective ont reçu une formation spécifique avant d'appliquer cette ordonnance collective. Pour maintenir son autorisation, l'infirmière devra assister à une mise à jour annuelle de cette formation et maintenir ses connaissances générales en santé des voyageurs.

Formulaire de liaison

Le formulaire de liaison est le document rempli par l'infirmière lors de la consultation. Ce formulaire doit comprendre les informations suivantes :

- La date de la consultation;
- L'identité de la personne (nom et date de naissance);
- Les médications recommandées avec leur posologie précise et la quantité requise;
- L'identité de l'infirmière ayant fait l'évaluation (nom, numéro de permis) ainsi que sa signature et le numéro téléphone où elle peut être jointe;
- L'identité du médecin répondant (nom, numéro de permis) ainsi que le numéro de téléphone où il peut être joint;
- Le lieu d'hébergement de l'ordonnance collective pour consultation par le pharmacien.

L'original du formulaire de liaison doit être remis au pharmacien par la personne. Le nom de toutes les médications recommandées doit être inscrit sur le formulaire de liaison et doit apparaître au dossier du patient.

Médecin répondant

Le médecin répondant est le médecin à qui le professionnel (infirmière ou pharmacien) peut s'adresser pour obtenir des précisions ou des informations supplémentaires. Le nom du médecin répondant, son numéro de permis d'exercice et un numéro de téléphone où il peut être joint doivent apparaître sur le formulaire de liaison.

Pendant les heures d'ouverture, tout médecin de l'équipe santé voyage ou le médecin de famille du patient pourra être consulté pour répondre aux questions de l'infirmière ou du pharmacien pour un patient ayant été vu à une des cliniques visées. Le dossier du patient devra lui être accessible. Le médecin devra noter au dossier toute information significative et toute modification de l'ordonnance et la date de cette modification.

C. Médications couvertes par cette ordonnance collective

En prophylaxie du paludisme :

- La chloroquine (Aralen®)
- L'association atovaquone-proguanil. (ATQ-PG ou Malarone®)

En traitement d'urgence de la diarrhée :

- La ciprofloxacine (Cipro XL® ou Cipro®)
- L'azithromycine (Zithromax®)
- La céfixime (Suprax®)

En traitement de la cystite récidivante

- La fosfomycine-trométhamine (Monurol)

En prophylaxie du mal aigu des montagnes

- L'acétazolamide (Diamox®)

C.1 Schémas prophylactiques contre le paludisme

Pour les voyages touristiques dans les zones impaludées, il faut envisager de recommander des médicaments pour réduire le risque de paludisme clinique chez certains voyageurs. Les voyageurs sont susceptibles d'être exposés au paludisme par des piqûres de moustiques pendant la soirée ou la nuit dans les zones à risque.
Les régions à risque peuvent être identifiées sur le Guide d'intervention santé voyage de l'INSPQ ou sur les sites web suivants ;

- Centers for disease control and prevention, au http://www.cdc.gov/malaria/risk_map/
- National Health Services de la Grande-Bretagne à www.fitfortravel.nhs.uk .

Ces sites donnent des informations mises à jour rapidement et sont considérés plus fiables que les cartes imprimées disponibles dans le Guide d'intervention santé-voyage du Québec. Ces régions incluent généralement :

Régions rurales et urbaines de : Haïti, d'Amérique du sud, d'Afrique, d'Asie et du sous-continent indien.

Certaines régions rurales: du Mexique et d'Amérique centrale.

Certaines zones touristiques : du Belize, du Guatemala, du El Salvador, du Honduras, du Nicaragua et du Panama.

Certaines régions touristiques (incluant les complexes hôteliers) : de la Jamaïque lorsqu'un avis de Santé Canada ou du CDC est en vigueur.

Au moment où ce protocole a été adopté, il n'y avait pas de risque de paludisme à Cuba et dans les autres îles des Antilles; en Argentine, au Chili, au Paraguay et en Uruguay ; dans les zones touristiques de l'Afrique du nord, notamment au Maroc, en Algérie, en Égypte, en Libye et en Tunisie; en Israël; à Oman; aux Émirats arabes unis; en Europe; en Turquie ; en Russie et en Chine .

Le tableau suivant donne un ordre de grandeur des risques moyens estimés de contracter le paludisme par mois de séjour, sans prophylaxie :

- Papouasie-Nouvelle-Guinée: 1/30
- Afrique sub-saharienne: 1/50
- Sous-continent indien: 1/250
- Asie du S-E: 1/1 000
- Amérique du Sud: 1/2 500
- Amérique centrale et Antilles: 1/10 000

Les mesures de protection personnelle doivent toujours être discutées avec le patient. Ces mesures représentent des outils importants dans la réduction du risque de paludisme et d'autres maladies transmises par des piqûres d'insectes telles que la fièvre dengue, la chikungunya, la fièvre jaune et plusieurs encéphalites. La réduction du risque pour ces mesures, bien utilisées, est d'environ 90%.

Il faut informer les voyageurs qu'aucune médication utilisée en prévention du paludisme n'assure une protection absolue. Les symptômes du paludisme peuvent apparaître à peine une semaine après l'arrivée en zone à risque et jusqu'à plusieurs mois après en être sorti. Chez la plupart des voyageurs qui contractent l'infection la plus grave à *P. falciparum*, les symptômes apparaissent dans les 3 mois suivant l'exposition. Son traitement, pour être efficace, doit débuter le plus rapidement possible.

Les infirmières et les pharmaciens visés par ce protocole ont la responsabilité d'informer les clients des risques importants associés au paludisme, même après leur retour.

UNE FIÈVRE QUI SE DÉCLARE CHEZ UN VOYAGEUR DANS LES 3 MOIS QUI SUIVENT SON RETOUR D'UNE RÉGION IMPALUDÉE EST CONSIDÉRÉE COMME UNE URGENCE MÉDICALE ET DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE INVESTIGATION SÉROLOGIQUE IMMÉDIATE.

C.1.1 Chloroquine

Nom commercial : Aralen®.

Indications : prophylaxie du paludisme.

La chloroquine (Aralen®) est un médicament de choix pour les voyageurs qui se rendent dans des régions visées par cette ordonnance collective.

Indications et efficacité :

Prise orale une fois par semaine, en commençant au moins 1 semaine avant l'arrivée dans la zone à risque, pendant toute la durée du séjour et pour 4 semaines après avoir quitté la zone à risque.

La chloroquine convient aux gens de tout âge et aux femmes enceintes mais les enfants de moins de 1 an et les femmes enceintes sont exclus de cette ordonnance collective.

Effets indésirables principaux, contre-indications et précautions :

- La chloroquine est généralement bien tolérée.
- Son goût est amer.
- Effets secondaires gastro-intestinaux (nausées et irritation gastrique) pouvant être réduits par la prise avec des aliments.
- Prurit généralisé possible chez les personnes de race noire, qui ne dénote pas nécessairement une allergie au médicament. Diriger vers un médecin pour évaluation.
- Vue brouillée possible au début de la prise de la médication (effet passager qui ne justifie pas l'interruption du traitement).
- Effets toxiques pour la rétine qui peuvent survenir après la prise quotidienne de fortes doses de chloroquine pendant une longue période (médicament utilisé pour traiter d'autres maladies); extrêmement rares lorsque la chloroquine est prise en prophylaxie de la malaria en doses hebdomadaires.
- Peut aggraver le psoriasis. Éviter chez les personnes souffrant de psoriasis.
- Convulsions et épisodes de psychose dans des cas isolés. Par conséquent, il ne faut pas donner de chloroquine aux personnes qui ont des antécédents d'épilepsie ou de psychose.

- Entrave la réponse au vaccin antirabique inoculé par voie intradermique.
  Contre-indications habituelles :
  - Hypersensibilité ou allergie à la chloroquine ou à ses dérivés (ex : nivaquine);
  - Hypersensibilité à l'une des composantes du médicament.
  - Épilepsie
  - Séjour en zone de résistance à la chloroquine (selon l'OMS)
  - Antécédents de modifications de la rétine ou du champ visuel;
  - Maladie hépatique active (hépatite, cirrhose)
  - Déficit connu en G-6-PD
  - Psoriasis

Contre-indications spécifiques à ce protocole :

- Enfant de moins de 1 an
- Grossesse (ou projet de grossesse pendant la prise de la médication)
- Maladie chronique grave incluant le diabète insulinodépendant , toute cardiopathie ischémique ou un antécédent d'accident vasculaire cérébral, une immunodéficience.
- Antécédent récent de cancer (traitement en cours ou fin depuis moins de 1 an), ou prise d'une médication induisant une immunosuppression.
- Vaccination en cours avec le vaccin antirabique inoculé par voie intradermique
- Antécédent de thrombo-embolie veineuse.
- Antécédent de convulsion ou d'épilepsie
- Utilisation de médicaments ou de substances pouvant entraver le métabolisme de la chloroquine : anticonvulsivants : carbamazépine, oxcarbazépine, primidone, topiramate, phénobarbital, phénytoïne;
- Prise d'anti-dépresseurs

C.1.2 Atovaquone-proguanil. (ATQ-PG)

Nom commercial : Malarone®.

- Comprimés adultes avec une association fixe de 250 mg d'atovaquone et de 100 mg de proguanil.
- Comprimés pédiatriques avec une association fixe de 62,5mg d'atovaquone et de 25 mg de proguanil.

Indications : prophylaxie du paludisme et traitement d'urgence du paludisme.

L'atovaquone-proguanil est un médicament de choix pour les voyageurs qui se rendent dans des régions visées par cette ordonnance collective.

Indications et efficacité :

Comprimés avec une association fixe d'atovaquone et de proguanil. Ces deux substances ont un effet synergique dans la prévention du paludisme. Efficacité

démontrée à titre d'agent prophylactique causal (agissant au stade hépatique) et suppresseur (agissant au stade sanguin).

Prise orale une fois par jour, en commençant 1 jour avant l'arrivée dans la zone à risque, pendant toute la durée du séjour et pour 7 jours après avoir quitté la zone à risque.

L'association atovaquone-proguanil convient aux gens de tout âge mais les enfants de moins de 1 an et les femmes enceintes sont exclus de cette ordonnance collective. L'association atovaquone-proguanil est également utilisée dans le traitement du paludisme aigu.

Pour les voyageurs à faible risque qui souhaitent apporter avec eux un traitement d'urgence contre le paludisme, l'atovaquone-proguanil sera prescrite à 4 comprimés adulte par jour pour 3 jours. Un voyageur qui suspecte un cas de paludisme doit consulter un médecin le plus rapidement possible.

Effets indésirables principaux, contre-indications et précautions :

- Excellent profil d'innocuité et de tolérance pour la prophylaxie du paludisme.
- Effets indésirables graves rares : convulsions ou éruptions cutanées.
- Fièvre et éruptions cutanées chez des patients porteurs du VIH.
- Aphtes (ulcères dans la bouche) possibles.

Contre-indications habituelles :

- Hypersensibilité ou allergie à l'atovaquone, au proguanil ou à l'une des composantes du médicament (ex : Mepron).
- Atteinte rénale grave
- Grossesse (ou projet de grossesse pendant la prise de la médication)

Contre-indications spécifiques à ce protocole :

- Enfant de moins de 1 an
- Maladie chronique grave incluant le diabète insulinodépendant, toute cardiopathie ischémique ou un antécédent d'accident vasculaire cérébral, une immunodéficience.
- Antécédent de thrombo-embolie veineuse.
- Antécédent récent de cancer (traitement en cours ou fin depuis moins de 1 an), ou prise d'une médication induisant une immunosuppression.
- Prise d'anti-dépresseurs, sauf pour la vortioxetine (Trintellix) et la paroxetine (Paxil) avec qui l'atovaquone-proguanil n'a pas d'interaction.

Résumé des questions à aborder au moment de discuter de la prophylaxie du paludisme avec un patient[1] :

- Le paludisme est une maladie potentiellement mortelle

[1] Recommandations canadiennes pour la prévention et le traitement du paludisme (malaria) chez les voyageurs internationaux http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/04vol30/30s1/page3_f.html

- Les médicaments utilisés en prévention du paludisme entraînent rarement des effets indésirables graves s'ils sont utilisés correctement
- La médication recommandée doit être prise selon le mode d'emploi prescrit
- Un essai pour évaluer la tolérance est possible avant le voyage, habituellement quelques jours de plus suffiront.
- Si le patient craint de ne pas tolérer un médicament, proposez-lui en un autre selon les zones de résistance ou le faire voir par le médecin.
- Il est possible de changer de médicament en présence d'effets indésirables graves.
- N'insistez pas auprès du patient pour qu'il prenne un médicament en particulier
- Si le patient tolère bien l'antipaludéen recommandé, il devrait continuer à le prendre peu importe ce que d'autres voyageurs ou résidents pourront lui dire.
- Le patient doit avoir l'option de voir le médecin pour discuter de son ordonnance.

C.2 Traitement d'urgence de la diarrhée

C.2.1 Ciprofloxacine

Nom commercial : Cipro[md], Cipro XL[md,] Ciprofloxacine

- Comprimés XL (à libération prolongée) de 500 et 1000mg
- Comprimés réguliers de 250, 500 et 750 mg.

Indications et efficacité :

- Prise orale une fois par jour (comprimés XL), pour 1 à 3 jours, en commençant en présence d'une diarrhée significative.
- Prendre 1000 mg stat suivi de 500 mg bid ou 1000 mg XL die.
- Débuter immédiatement en présence de sang dans les selles ou de fièvre accompagnant la diarrhée.
- Consulter un médecin le plus rapidement possible si les symptômes persistent ou s'aggravent malgré le traitement.
- Cesser le traitement si les symptômes sont contrôlés.
- Peut être utilisé en traitement d'urgence de l'infection urinaire basse chez la femme.

La ciprofloxacine convient aux adultes en bonne santé présentant des symptômes de diarrhée aiguë. Cette médication est indiquée pour permettre aux voyageurs de se traiter rapidement en présence de symptômes, évitant ainsi les risques de complications associées à un retard de traitement (*ou de complications chroniques associées tel que le syndrome du côlon irritable)* et les risques d'infections transmises par le sang associées à des soins médicaux dans des régions réutilisant le matériel médical.

La résistance à la ciprofloxacine est répandue et une absence de réponse rapide au traitement devrait motiver une consultation médicale.

Effets indésirables principaux, contre-indications et précautions :

Généralement bien toléré. Effets indésirables possibles : Mal de dos, douleurs thoraciques, douleurs, douleurs aux membres, candidose; palpitations, phlébite, tachycardie, thrombophlébite; douleurs abdominales, anorexie, sécheresse de la bouche, dyspepsie, dysphagie, distension abdominale, flatulence, candidose gastro-intestinale, ictère, stomatite, vomissements, anomalies des épreuves fonctionnelles hépatiques; agranulocytose, anémie, éosinophilie, granulopénie, leucopénie, leucocytose, pancytopénie; éruptions cutanées; hausse de la créatinine; agitation, confusion, convulsions, étourdissements, hallucinations, céphalées, hyperesthésie, augmentation de la transpiration, insomnie, somnolence, tremblements; albuminurie, hématurie.

Contre-indications habituelles :

- Hypersensibilité ou allergie à la ciprofloxacine, à tout autre quinolone ou à ses dérivés (lévofloxacine (Levaquin), ofloxacine (Floxin), moxifloxacine (Avelox), norfloxacine (Noroxin), acide nalidixique) ; Hypersensibilité à l'une des composantes du médicament.
- Maladie hépatique active (hépatite, cirrhose)
  Utilisation de médicaments ou de substances dont le métabolisme peut être entravé par la ciprofloxacine : tizanidine (Zanaflex, un anti-spasmodique, relaxant musculaire); anticoagulants oraux de type coumadin ou edoxan (lixiana) et les dérivés de la théophylline, le méthotrexate, la cyclosporine et la clozapine ; un antidépresseur du nom de agomelatinine (Valdoxan, Melitor et Thymanax), un sédatifs-hypnotiques du nom de zolpidem (Ambien ou Stilnox).
- Enfant de moins de 18 ans
- Grossesse (ou projet de grossesse pendant la prise de la médication) et allaitement

Contre-indications spécifiques à ce protocole:

- Antécédents d'épilepsie ou de convulsions
- Maladie chronique grave incluant le diabète insulinodépendant , toute cardiopathie ischémique ou un antécédent d'accident vasculaire cérébral, une immunodéficience.
- Antécédent de thrombo-embolie veineuse.
- Antécédent récent de cancer (traitement en cours ou fin depuis moins de 1 an), ou prise d'une médication induisant une immunosuppression.
- Utilisation de médicaments ou de substances dont le métabolisme peut être entravé par la ciprofloxacine : anticoagulants oraux de type coumadin ou edoxan (lixiana) ; théophylline ;
- Prise d'anti-dépresseurs, sauf pour la vortioxetine (Trintellix) et la paroxetine (Paxil) avec qui cipro n'a pas d'interaction.

C.2.2 Azithromycine (Zithromax)

Nom commercial : Zithromax

- Comprimés de 250 et 600 mg.
- Poudre pour suspension orale pédiatrique (100 mg/5 mL ou 200 mg/5 mL): Peut être administré avec ou sans nourriture.

Indications et efficacité :

- Prise orale une fois par jour de 500 ou 600 mg, pour 1 à 3 jours, en commençant en présence d'une diarrhée significative.
- Débuter immédiatement en présence de sang dans les selles ou de fièvre accompagnant la diarrhée.
- Consulter un médecin le plus rapidement possible si les symptômes persistent ou s'aggravent malgré le traitement.
- Cesser le traitement dès que les symptômes sont contrôlés.

L'azithromycine convient aux adultes et aux enfants en bonne santé présentant des symptômes de diarrhée aiguë. Cette médication est indiquée pour permettre aux voyageurs de se traiter rapidement en présence de symptômes, évitant ainsi les risques de complications associées à un retard de traitement (*ou de complications chroniques associées tel que le syndrome du côlon irritable)* et les risques d'infections transmises par le sang associées à des soins médicaux dans des régions réutilisant le matériel médical.

La résistance à l'azithromycine est de plus en plus répandue et une absence de réponse rapide au traitement devrait motiver une consultation médicale.

L'azithromycine n'est pas indiquée dans la prophylaxie du paludisme.

Effets indésirables principaux, contre-indications et précautions :

Effets indésirables de nature digestive: nausées, vomissements, diarrhée associée à des douleurs abdominales; Parmi les effets indésirables potentiellement dangereux associés au traitement, on compte l'oedème angioneurotique, l'ictère cholestatique, la colite pseudomembraneuse et la pancréatite qui se sont produits chez moins de 1 % des patients.

Contre-indications habituelles

- Hypersensibilité ou allergie à l'azithromycine, à tout autre macrolide ou à ses dérivés (tels que toutes les érythromycines, clarithromycines, le Biaxin[md)], et le Pédiazole[md]);
- Hypersensibilité à l'une des composantes du médicament.
- Insuffisance hépatique et rénale

- Prise de médications telles que les alcaloïdes de l'ergot de seigle dihydroergotamine, ergotamine (contre la migraine), le cisapride (Prepulside), les agonistes dopaminergiques : bromocriptine, cabergoline, pergolide.
- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase.
- Myasthénie grave
- Allaitement d'un bébé allergique à l'azithromycine ou à tout macrolide ou ses dérivés
- Prise combinée avec une ou plusieurs médications pouvant prolonger l'interval Q-T.

Contre-indications spécifiques à ce protocole

- Enfants de moins de 1 mois
- Antécédents d'épilepsie ou de convulsions
- Maladie chronique grave incluant le diabète insulinodépendant, toute cardiopathie ischémique ou un antécédent d'accident vasculaire cérébral, une immunodéficience.
- Antécédent de thrombo-embolie veineuse.
- Antécédent récent de cancer (traitement en cours ou fin depuis moins de 1 an), ou prise d'une médication induisant une immunosuppression.
- Prise d'anti-dépresseurs, sauf pour la vortioxetine (Trintellix) et la paroxetine (Paxil) avec qui l'azithromycine n'a pas d'interaction.

C.2.3 Céfixime (Suprax)

Nom commercial : Suprax

- Comprimés de 400 mg
- Poudre pour suspension orale pédiatrique (100 mg/5 mL): Peut être administré avec ou sans nourriture.

Indications et efficacité :

- Prise orale une fois par jour, pour 1 à 5 jours, en commençant en présence d'une diarrhée significative.
- Débuter immédiatement en présence de sang dans les selles ou de fièvre accompagnant la diarrhée.
- Consulter un médecin le plus rapidement possible si les symptômes persistent ou s'aggravent malgré le traitement.
- Cesser le traitement dès que les symptômes sont contrôlés.

La céfixime convient aux adultes et aux enfants de 6 mois et plus en bonne santé présentant des symptômes de diarrhée aiguë. Cette médication est indiquée pour

permettre aux voyageurs de se traiter rapidement en présence de symptômes, évitant ainsi les risques de complications associées à un retard de traitement (*ou de complications chroniques associées tel que le syndrome du colon irritable)* et les risques d'infections transmises par le sang associées à des soins médicaux dans des régions réutilisant le matériel médical. C'est un traitement de choix contre la shigellose.

La résistance à la céfixime est de plus en plus répandue et une absence de réponse rapide au traitement devrait motiver une consultation médicale.

Effets indésirables principaux, contre-indications et précautions :

Effets indésirables de nature digestive dont parfois la diarrhée, des céphalées ou des vertiges.

Contre-indications habituelles

- Hypersensibilité ou allergie à la céfixime ou aux pénicillines (pénicilline, amoxicilline, cloxacilline);
- Hypersensibilité à l'une des composantes du médicament.
- Insuffisance rénale sévère

Contre-indications spécifiques à ce protocole

- Enfants de moins de 1 mois
- Antécédents d'épilepsie ou de convulsions
- Maladie chronique grave incluant le diabète insulinodépendant, toute cardiopathie ischémique ou un antécédent d'accident vasculaire cérébral, une immunodéficience.
- Antécédent de thrombo-embolie veineuse.
- Antécédent récent de cancer (traitement en cours ou fin depuis moins de 1 an), ou prise d'une médication induisant une immunosuppression.

C.3 Traitement en voyage de la cystite récidivante non compliquée Monurol

Clientèle, catégories de clientèles ou situation clinique visée

- Toute femme de 18 à 65 ans qui part en voyage et qui a présenté dans le passé des épisodes non compliqués d'infection urinaire.

Contre-indications / Limites

- Moins de 18 ans et plus de 65 ans
- Sexe masculin
- Signes et symptômes d'infection urinaire haute (To, douleur lombaire, état général)
- Anomalie anatomique de l'arbre urinaire
- Femme porteuse de sonde urinaire ou qui doit avoir des cathétérismes urinaires régulièrement
- Chirurgie récente de l'arbre urinaire (< 3 mois)

- Immunosuppression
- Hématurie macroscopique
- Diabète
- Présence d'insuffisance rénale (≤ 60cc/min de ClCr) au dossier ou dans les antécédents de la patiente
- Présentation clinique suggérant davantage une infection vaginale ou ITSS (voir questionnement)
- Symptôme évoluant depuis plus de 7 jours ou traitement récent d'infection urinaire (< 1 mois)
- Grossesse
- Histoire de 2 infections urinaires en 6 mois ou au moins 3 infections urinaires en 1 an pour évaluer l'intérêt d'une prophylaxie.

Interaction médicamenteuse :

- Métoclopramide
- Probénécide.

C.3.1 Monurol

MonurolMD Sachet (fosfomycine-trométhamine) monodose :

Sig : Un sachet monodose ajouté à environ 125 mL (1⁄2 tasse) d'eau froide, mélangé afin de le dissoudre et pris immédiatement par voie orale.

Il est recommandé de prendre **MONUROL** (fosfomycine trométhamine) à jeun ou au moins 2 à 3 heures après un repas.

- La patiente devrait avoir une amélioration de ses symptômes après 24h de traitement antibiotique

- Aviser la patiente de reconsulter si les symptômes persistent au-delà du traitement ou s'ils augmentent après le début du traitement

C.4 Prévention du mal aigu des montagnes (MAM) (pour les infirmières ayant reçu une formation spécifique supplémentaire)

Conseils généraux pour la prévention du mal aigu des montagnes (MAM):

La méthode la plus sûre est l'ascension progressive.

- Éviter une ascension rapide jusqu'à une altitude de sommeil au-dessus de 3 000 m (9 840 pi) et passer de 2 à 3 nuits à une altitude de 2 500 m à 3 000 m (8 200 pi à 9 840 pi) avant de poursuivre l'ascension.
- Recommander de passer une nuit d'acclimatation à chaque gain supplémentaire d'altitude de 600 à 900 m (1 970 pi à 2 950 pi).
- Éviter l'alcool et les sédatifs.
- Encourager une alimentation riche en glucides (> 70 %).
- Éviter le surmenage mais encourager l'exercice modéré.

C.4.1 Acétazolamide (Diamox)

Nom commercial : Apo-acetazolamide, Diamox

- Comprimés de 125 et 250 mg

Indications et efficacité :

- *Ascension rapide à des altitudes > 2 500 m (fortement recommandé);*
- *Augmentation rapide de l'altitude de sommeil*
- *Antécédents de Mal Aigu des Montagnes (MAM) ou d'Oedème Pulmonaire de Haute Altitude (OPHA).*

Prise orale de 125 à 1000 mg par jour, en une ou deux prises par jour, en commençant 1 ou 2 jours avant l'ascension et en poursuivant pour au moins 2 jours après avoir atteint la plus haute altitude du parcours. Débuter avec 125 mg au coucher. Augmenter la dose progressivement selon l'altitude atteinte et les symptômes ressentis. Consulter un médecin le plus rapidement possible si les symptômes persistent ou s'aggravent malgré le traitement. Cesser le traitement dès la descente à 2500 mètres d'altitude ou moins.

L'acétazolamide convient aux adultes et aux enfants de 12 ans et plus en bonne santé

Effets indésirables principaux, contre-indications et précautions :

Les effets secondaires de l'acétazolamide incluent

- paresthésies
- polyurie
- nausées
- somnolence
- impuissance
- myopie.
- modification du goût des boissons gazéifiées, y compris celui de la bière

Contre-indications habituelles

- Hypersensibilité ou allergie à l'acétazolamide
- Hypersensibilité à l'une des composantes du médicament
- Glaucome chronique
- Grossesse et allaitement
- Insuffisance hépatique et rénale
- Insuffisance surrénalienne
- Prise de médications telles que les Amphétamines; les Bêtabloqueurs; les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (eg, methazolamide); la Cyclosporine; les antagonistes de l'acide folique tels que le 5-AAS, les corticostéroïdes et la

cholestyramine (Questran); les anti-épileptiques tels que la phénytoïne, la Primidone et le Topiramate (Topamax); le Lithium; la Quinidine; la méthénamine (antiseptique urinaire); les salicylates; et le bicarbonate de soude.

Contre-indications spécifiques à ce protocole

- Antécédent de convulsion ou d'épilepsie ou de psychose (incluant la schizophrénie et les troubles bi-polaires)
- Maladie chronique grave incluant le diabète insulinodépendant, toute cardiopathie ischémique ou un antécédent d'accident vasculaire cérébral, une immunodéficience.
- Antécédent de thrombo-embolie veineuse.
- Antécédent récent de cancer (traitement en cours ou fin depuis moins de 1 an), ou prise d'une médication induisant une immunosuppression.
- Antécédent de Mal aigu des montagnes ou d'oedème pulmonaire en altitude.
- Prise d'anti-dépresseurs

C.5. Traitement d'urgence de l'anaphylaxie

La gravité d'une réaction allergique, de même que celle des symptômes, peut varier d'une personne à l'autre et d'une phase à l'autre chez la même personne.
Pour les patients présentant des allergies reconnues, l'infirmière pourra prescrire les médicaments suivants:

- Allerject 0,3 mg et Allerject junior 0,15 mg
- Epipen 0,3 mg et Epipen junior 0,15 mg
- Emerade 0,3 mg ou 0,5 mg

C.5.1 Dose des auto-injecteurs

Chaque dispositif auto-injecteur contient une dose unique d'adrénaline à administration automatique et ne doit être utilisé que par un seul patient. Le Twinject contient 2 doses, mais la deuxième dose doit être administrée manuellement.

Il existe deux doses différentes. Le choix de la posologie adéquate est déterminé en fonction du poids corporel du patient.

0,15 mg

Convient aux patients qui pèsent entre 15 et 30 kg (33-66 livres). On recommande d'utiliser la dose adulte dès un poids de 25 kg.

0,3 mg

Convient aux patients qui pèsent au moins 30 kg (66 livres).

Recommander aux patients de visiter les Sites web pour enseignement de la technique, obtenir un démonstrateur et pour s'enregistrer et obtenir une alerte de renouvellement:

0,5 mg (Emerade seulement)

Convient aux patients qui pèsent au moins 60 kg (125 livres).

Recommander aux patients de visiter les Sites web pour l'enseignement de la technique, obtenir un démonstrateur et pour s'enregistrer et obtenir une alerte de renouvellement:

http://www.allerject.ca
http://www.epipen.ca/fr/
https://www.emerade.ca/fr

D. Rédaction du formulaire de liaison et vérifications

Identification des professionnels

Signature

L'infirmière doit apposer sa signature sur le formulaire de liaison.

Identification du patient

De façon réglementaire, l'identification du patient sur le formulaire de liaison doit comprendre : les nom et prénom et la date de naissance. Dans certains cas, il peut être utile d'y ajouter l'adresse, le sexe ou le numéro de téléphone du patient.

Le formulaire de liaison devra inclure les données suivantes:

- le nom intégral du médicament;
- la posologie, incluant la forme pharmaceutique, la concentration, le dosage;
- la voie d'administration;
- la durée du traitement ou la quantité recommandée;
- et, lors d'ajustement, l'intention thérapeutique;

E. Tenue de dossiers

La note au dossier doit être rédigée au cours de la consultation ou immédiatement après. Le questionnaire médical doit être révisé et toutes les informations obtenues inscrites au dossier.

L'Infirmière inscrira le choix des médications au dossier du patient.

- S'assurer que le nom et la date sont inscrits
- Signer en s'identifiant lisiblement
- Indiquer le nom du médecin de garde lors de cette consultation

F. Communications avec les patients, les pharmaciens et les collègues:

- Toujours noter au dossier du patient un entretien téléphonique avec lui.
- Imprimer et verser au dossier les échanges par courriel ou tout autre médium.

- Écrire lisiblement

G. Médecins signataires

Dr Martin Brizard et Dre Dominique Tessier sont les médecins signataires pour ce protocole.

H. Site d'hébergement du protocole de l'ordonnance collective

Pour que les pharmaciens puissent avoir accès au besoin au protocole en lien avec le formulaire de liaisons qui leur sera remis par les patients, une copie abrégée de l'ordonnance collective à jour sera disponible sur le site du Groupe Santé voyage à l'adresse indiquée sur le formulaire de liaison.

I. Documentation

L'évaluation du risque de paludisme et de diarrhée du voyageur :

L'évaluation du risque de paludisme pour le voyageur devra se faire en fonction des données officielles les plus récentes disponibles. L'évaluation du risque de diarrhée pour le voyageur devra se faire en fonction des données officielles les plus récentes disponibles. En l'absence de communiqué spécifique envoyé à tous les membres de l'équipe par Dr Tessier ou par Dr Brizard, seront considérés comme des documents de référence fiables les communiqués :

- De l'Organisation mondiale de la santé
- Du Centers for Disease Control and Prevention (CDC), incluant les ProMed.
- Du Comité consultatif de la médecine tropicale et de la médecine des voyages (CCMTMV) ou de Santé Canada, incluant la mise à jour 2023 : Annexe 1 : Risque de paludisme et mesures préventives recommandées par région géographique.
- Du Comité consultatif québécois sur la médecine des voyages (CCQSV)
- De l'Institut de santé publique du Québec
- National Health Institute de la Grande Bretagne (www.fitfortravel)

Les liens url pour ces sites sont disponibles sur la page du Groupe santé voyage.Cet outil est la ressource privilégiée par l'équipe du groupe santé voyage.

La prévention du mal aigu des montagnes (MAM)

Le document *Déclaration sur les maladies de haute altitude* (http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/07vol33/acs-05/index-fra.php) a servi de cadre de référence pour le mal des montagnes. Les mises à jour ont été faites en utilisant comme référence le Yellow Book 2020 (Chapter 3, Environmental Hazards & Other Noninfectious Health Risks,

https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2020/noninfectious-health-risks/high-altitude-travel-and-altitude-illness)

https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2020/noninfectious-health-risks/high-altitude-travel-and-altitude-illness)

Lorsque les recommandations de plusieurs avis sont contradictoires, il faudra se référer à un avis récent émis par le directeur médical de la clinique ou consulter le médecin de garde pour obtenir un avis.

J. Signataires

Une copie portant la signature de tous les intervenants est conservée à la Clinique Santé voyage, à Laval

Médecins :

Dr Martin Brizard
Directeur médical, Groupe Santé voyage

Dre Dominique Tessier
Directeur médical, Cliniques du Groupe santé voyage

Infirmières :

Guylaine Dionne, infirmière

Daphné Paiva, infirmière

Kikalulu Mawa, infirmière

K. Annexes

Annexe 1 Médicaments utilisés pour la prévention du paludisme chez les adultes et les adolescents inclus dans ce protocole[2].

2.Adapté de Recommandations canadiennes pour la prévention et le traitement du paludisme (malaria) chez les voyageurs internationaux, supplément. 2004

Médicament Nom générique	Posologie Adultes	Avantages	Inconvénients	Effets indésirables
ATOVAQUONE-PROGUANIL (Malarone®) **Comprimé pour adultes :** 250 mg atovaquone et 100 mg proguanil	Prendre 1 comprimé par jour Débuter au moins 1 jour avant le départ Poursuivre 7 jours après avoir quitté la zone à risque de paludisme Traitement : Prendre 4 co par jour pour 3 jours. Consulter un médecin le plus rapidement possible	Prophylaxie causale – Ne doit être poursuivie que pendant 7 jours après l'exposition	Le médicament doit être pris chaque jour pour la prophylaxie	**Fréquents :** Nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée, élévation des transaminases. **Rares :** convulsions, éruptions cutanées, ulcères buccaux.
CHLOROQUINE (Aralen®) Comprimé : 250 mg, (correspondant à 150 mg base)	Prendre 2 comprimés une fois/semaine. Débuter au moins 1 sem. avant le départ Poursuivre 4 sem. après avoir quitté la zone à risque de paludisme	Données confirmant son innocuité en prophylaxie à long terme	Chloroquino-résistance maintenant présente dans la plupart des régions	**Fréquents :** Prurit chez les personnes de race noire, nausées, céphalées. **Peu fréquents :** Éruptions cutanées, opacité cornéenne réversible. **Rares :** Coloration anormale des ongles et des muqueuses, alopécie partielle, photophobie, surdité nerveuse, myopathie, rétinopathie avec usage quotidien, dyscrasies, épisodes de psychose et convulsions.

Annexe 2 Médicaments utilisés pour la prévention du paludisme chez les enfants inclus dans ce protocole[3].

Médicament Nom générique	Posologie Enfants (dose en comprimés pédiatriques)	Avantages	Inconvénients	Effets indésirables
ATOVAQUONE-PROGUANIL (Malarone®) **Comprimé pédiatrique :** 62,5 mg atovaquone et 125mg proguanil	5 à 8 kg : ½ co 9 à 10 kg : ¾ co 11 à 20 kg : 1 co 21 à 30 kg : 2 co 31 à 40 kg : 3 co > 40 kg : 4 co ped ou 1 co adulte Prendre 1 dose par jour Débuter au moins 1 jour avant le départ Poursuivre 7 jours après avoir quitté la zone à risque de paludisme	Prophylaxie causale – Ne doit être poursuivie que pendant 7 jours après l'exposition	Le médicament doit être pris chaque jour pour la prophylaxie	**Fréquents :** Nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée, élévation des transaminases. **Rares :** convulsions, éruptions cutanées, ulcères buccaux.
CHLOROQUINE (Aralen®) Comprimé : 250 mg, (correspondant à 150 mg base)	< 10 kg : ¼ co 10 à 19 kg : ½ co 20 à 30 kg : 1 co 31 à 45 kg : 1 ½ co > 45 kg : 2 co Prendre 1 dose une fois/semaine. Débuter au moins 1 sem. Avant le départ Poursuivre 4 sem. Après avoir quitté la zone à risque de paludisme	Données confirmant son innocuité en prophylaxie à long terme	Chloroquino-résistance maintenant présente dans la plupart des régions	**Fréquents :** Prurit chez les personnes de race noire, nausées, céphalées. **Peu fréquents :** Éruptions cutanées, opacité cornéenne réversible. **Rares :** Coloration anormale des ongles et des muqueuses, alopécie partielle, photophobie, surdité nerveuse, myopathie, rétinopathie avec usage quotidien, dyscrasies, épisodes de psychose et convulsions.

[3] **Adapté de Recommandations canadiennes pour la prévention et le traitement du paludisme (malaria) chez les voyageurs internationaux, supplément. 2004**

Annexe 3 Formulaire de liaison: Adultes et adolescents

ORDONNANCE COLLECTIVE	Initier un traitement prophylactique ou curatif pour les voyageurs.	
Référence au protocole : « Ordonnance collective : Médications pour la prévention du paludisme et le traitement de la diarrhée chez les voyageurs, Cliniques du Groupe Santé voyage. » Voir www.cliniquesantevoyage.com/pharmaciens4 pour le protocole.	Date de mise en Vigueur : 1 mars 2012	Date de révision : Avril 2023
Les infirmières des Cliniques du Groupe Santé voyage sont habilitées et possèdent la formation, les connaissances et les compétences nécessaires.		
Groupe de personnes visées ou situation clinique visée : Clientèle des cliniques du Groupe Santé voyage		
Activités réservées : · Évaluer le voyageur et ses conditions de voyage; · Initier des mesures prophylactiques ou thérapeutiques;		

Nom et prénom : _____

Date de naissance :

Voyage de ____ semaine(s) Pays :_____

Selon la procédure établie, je recommande, après évaluation de ce patient, en tenant compte de sa destination et de sa condition médicale, en l'absence de contre-indication et après lui avoir donné les conseils préventifs d'usage:

1. Phosphate de Chloroquine (Aralen) 250 mg **# _____**

Sig : 500 mg une fois par semaine, de préférence après un repas

Commencer une semaine avant l'arrivée, poursuivre durant tout le séjour et durant 4 semaines après la sortie de la zone de malaria (paludisme).

2. ATOVAQUONE/PROGUANIL (Malarone) 250 mg/100 mg

Prophylaxie : Sig : 1 co une fois par jour **# _____**

Commencer au moins un jour avant l'arrivée, poursuivre durant tout le séjour et durant 7 jours après la sortie de la zone de malaria (paludisme).

Traitement : Sig : 4 co une fois par jour pour 3 jours **# _____**

Commencer dès l'apparition d'une forte fièvre plus de 7 jours après un séjour en zone de paludisme. Consulter le plus rapidement possible pour confirmer le diagnostic.

3. Ciprofloxacine (Cipro) ☐ **1000 mg XL ou** ☐ **500 mg** **# _____**

Sig : 1000 mg stat puis 1000 mg XL die ou 500 mg bid pour 1 à 3 jours.

Diarrhée : Commencer dès le début d'une diarrhée significative.Cesser dès amélioration.

4. Azithromycine (Zithromax) ☐ **250 mg (ou** ☐ **600 mg si 250 mg non disponible)** **# _____**

Sig : 500 mg (ou 600 mg) une fois par jour pour 1 à 3 jours

Diarrhée : Commencer dès le début d'une diarrhée significative.Cesser dès amélioration.

5. Céfixime (Suprax) 400 mg **# _____**

Sig : 1 co une fois par jour, pour 1 à 3 jours

Diarrhée : Commencer dès le début d'une diarrhée significative. Prendre 1 co par jour pour 1 à 5 jours

6. Acétazolamide (Diamox) 250 mg **# _____**

Sig : 125 à 250 mg pris une à deux fois par jour

Commencer avec 125 mg au coucher au moins un jour avant l'arrivée en altitude et poursuivre durant toute l'ascension et pour 2 à 3 jours par la suite. Augmenter la dose selon les symptômes ressentis. Consulter un médecin en présence de symptômes persistants.

_____ _____

infirmière No de permis de l'O.I.I.Q. :

Annexe 4 Formulaire de liaison: Enfants voyageurs

ORDONNANCE COLLECTIVE	Initier un traitement prophylactique ou curatif pour les voyageurs.	
Référence au protocole : « Ordonnance collective : Médications pour la prévention du paludisme et le traitement de la diarrhée chez les voyageurs, Cliniques du Groupe Santé voyage. » www.cliniquesantevoyage.com/pharmaciens3 pour le protocole.	Date de mise en vigueur : 24 janvier 2011	Date de révision : juin 2022
Les infirmières des Cliniques du Groupe Santé voyage sont habilitées et possèdent la formation, les connaissances et les compétences nécessaires.		
Groupe de personnes visées ou situation clinique visée : Clientèle des cliniques du Groupe Santé voyage		
Activités réservées : · Évaluer le voyageur et ses conditions de voyage; · Initier des mesures prophylactiques ou thérapeutiques;		

Nom et prénom : _____
Date de naissance : _____
Voyage de ____ semaine(s) Pays :_____

Poids de l'enfant : ____ Kg

Selon la procédure établie, je recommande, après évaluation de ce patient, en tenant compte de sa destination et de sa condition médicale, en l'absence de contre-indication et après lui avoir donné les conseils préventifs d'usage:

1. Phosphate de Chloroquine (Aralen) 250 mg # _____

- < 10 kg : ¼ co
- 10 à 19 kg : ½ co
- 20 à 30 kg : 1 co
- 31 à 45 kg : 1 ½ co
- > 45 kg : 2

Sig : Prendre ___ co une fois par semaine, de préférence après un repas. Commencer une semaine avant l'arrivée, poursuivre durant tout le séjour et durant 4 semaines après la sortie de la zone de malaria (paludisme).

2. Atovaquone/proguanil (Malarone) 62,5 mg/25 mg # _____ co péd.

- 5 à 8 kg : ½ co
- 9 à 10 kg : ¾ co
- 11 à 20 kg : 1 co
- 21 à 30 kg : 2 co
- 31 à 40 kg : 3 co
- > 40 kg : 4 co ped

Sig : Prendre __ co pédiatrique une fois par jour

Commencer au moins un jour avant l'arrivée, poursuivre durant tout le séjour et durant 7 jours après la sortie de la zone de malaria (paludisme).

3. **Azithromycine (Zithromax)** Poudre pour suspension orale pédiatrique.

Ne pas reconstituer jusqu'à ce que requis.

- 10 mg / kg/jour pour 1 à 3 jours si diarrhée
- 10 mg / kg/jour, le premier jour puis 5 mg / kg/jour, les jours 2 à 5 si infection respiratoire (consulter un médecin)

_____ _____

Infirmière No de permis de l'O.I.I.Q. :

Protocole disponible pour référence au www.cliniquesantevoyage.com/pharmaciens3. Nom des médecins répondants : Martin Brizard (# 185-324) Dominique Tessier (# 182-621) ou médecin en service à la clinique santé voyage. Téléphone : (450) 629-1120

Annexe 5 Contre-indications à la chloroquine (Phosphate de CHLOROQUINE, Aralen)

Contre-indications habituelles	· Hypersensibilité ou allergie à la chloroquine ou à ses dérivés (ex : nivaquine); Hypersensibilité à l'une des composantes du médicament. · Épilepsie · Séjour en zone de résistance à la chloroquine (selon l'OMS) · Antécédents de modifications de la rétine ou du champ visuel; · Maladie hépatique active (hépatite, cirrhose) · Déficit connu en G-6-PD · Psoriasis
Contre-indications spécifiques à cette ordonnance collective (puisque nécessitant une consultation médicale)	· Enfant de 1 an ou moins · Grossesse (ou projet de grossesse pendant la prise de la médication) · Maladie chronique grave incluant le diabète insulinodépendant, toute cardiopathie ischémique ou un antécédent d'accident vasculaire cérébral, une immunodéficience. · Vaccination en cours avec le vaccin antirabique inoculé par voie intradermique · Antécédent de thrombo-embolie veineuse. · Antécédent de convulsion ou d'épilepsie · Antécédent de cancer (fin des traitements depuis moins de 1 an) · Prise d'anti-dépresseurs

Effets secondaires courants	• Goût est amer. • Gastro-intestinaux : nausées et irritation gastrique. • Prurit généralisé possible chez les personnes de race noire, qui ne dénote pas nécessairement une allergie au médicament. Diriger vers un médecin pour évaluation. • Vue brouillée (effet passager qui ne justifie pas l'interruption du traitement). • Effets toxiques pour la rétine qui peuvent survenir après la prise quotidienne de fortes doses de chloroquine pendant une longue période (médicament utilisé pour traiter d'autres maladies); extrêmement rares lorsque la chloroquine est prise en prophylaxie de la malaria en doses hebdomadaires. • Peut aggraver le psoriasis. • Convulsions et épisodes de psychoses dans des cas isolés. • Entrave la réponse au vaccin antirabique inoculé par voie intradermique.

Annexe 6 Contre-indications à l'association atovaquone-proguanil (Malarone md)

Contre-indications habituelles	· Hypersensibilité ou allergie à l'atovaquone, au proguanil ou à l'une des composantes du médicament (ex : mepron). · Atteinte rénale grave · Grossesse (ou projet de grossesse pendant la prise de la médication) · Allaitement
Contre-indications spécifiques à cette ordonnance collective (puisque nécessitant une consultation médicale)	· Enfant de 1 an ou moins · Maladie chronique grave incluant le diabète insulinodépendant, toute cardiopathie ischémique ou un antécédent d'accident vasculaire cérébral, une immunodéficience. · Antécédent de thrombo-embolie veineuse. · Antécédent de cancer (fin des traitements depuis moins de 1 an) · Prise d'anti-dépresseurs
Effets secondaires courants	• Convulsions et épisodes de psychoses dans des cas isolés. • Éruptions cutanées. • Fièvre et éruptions cutanées chez des patients porteurs du VIH. • Aphtes (ulcères dans la bouche) possibles.

Annexe 7 Contre-indications à la ciprofloxacine Ciprofloxacine (Cipro^{md})

Contre-indications habituelles	· Hypersensibilité ou allergie à la ciprofloxacine, à tout autre quinolone ou à ses dérivés (levofloxacine (Levaquin), ofloxacine (Floxin), moxifloxacine (Avelox), norfloxacine (Noroxin), acide nalidixique) ; Hypersensibilité à l'une des composantes du médicament. · Maladie hépatique active (hépatite, cirrhose) · Utilisation de médicaments ou de substances dont le métabolisme peut être entravé par la ciprofloxacine : tizanidine (Zanaflex, un anti-spasmodique, relaxant musculaire); anticoagulants oraux de type coumadin ou edoxan (lixiana) et les dérivés de la théophylline, le méthotrexate, la cyclosporine et la clozapine ; Peut être prescrit si prise des anticoagulants suivant : de Apixaban (Éliquis®), Dabigatran (Pradaxa®) ou Rivaroxaban (Xarelto®) · Enfant de moins de18 ans · Grossesse (ou projet de grossesse pendant la prise de la médication) et allaitement
Contre-indications spécifiques à cette ordonnance collective (puisque nécessitant une consultation médicale)	· Antécédents d'épilepsie ou de convulsions · Maladie chronique grave incluant le diabète insulinodépendant, toute cardiopathie ischémique ou un antécédent d'accident vasculaire cérébral, une immunodéficience. · Antécédent de thrombo-embolie veineuse. · Antécédent récent de cancer (traitement en cours ou fin depuis moins de 1 an) · Utilisation de médicaments ou de substances dont le métabolisme peut être entravé par la ciprofloxacine : anticoagulants oraux de type coumadin ou edoxan (lixiana) ; théophylline ; · Prise d'anti-dépresseurs
Effets secondaires courants	· Mal de dos, douleurs thoraciques, douleurs, douleurs aux membres, candidose · Palpitations, phlébite, tachycardie, thrombophlébite; · Douleurs abdominales, anorexie, sécheresse de la bouche, dyspepsie, dysphagie, distension abdominale, flatulence, candidose gastro-intestinale, ictère, stomatite, vomissements, · Anomalies des épreuves fonctionnelles hépatiques; agranulocytose, anémie, éosinophilie, granulopénie, leucopénie, leucocytose, pancytopénie; éruptions cutanées; · Hausse de la créatinine; agitation, confusion, convulsions, étourdissements, hallucinations, céphalées, hyperesthésie, augmentation de la transpiration, insomnie, somnolence, tremblements · Albuminurie, hématurie.

Annexe 8 Contre-indications à l'azithromycine (Zithromax[md])

Contre-indications habituelles	· Hypersensibilité ou allergie à l'azithromycine, à tout autre macrolides ou à ses dérivés (tels que érythromycine, clarithromycine, Biaxin[md], Clavulin[md]) ; Hypersensibilité à l'une des composantes du médicament. · Insuffisance hépatique et rénale · Prise de médications telles que les alcaloïdes de l'ergot de seigle : dihydroergotamine, ergotamine (contre la migraine), le cisapride (Prepulside), les agonistes dopaminergiques : bromocriptine, cabergoline, pergolide. · En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase · Myasthénie grave · Allaitement d'un bébé allergique à l'azithromycine ou à tout macrolide ou ses dérivés · Prise combinée avec une ou plusieurs médications pouvant prolonger l'interval Q-T.
Contre-indications spécifiques à cette ordonnance collective (puisque nécessitant une consultation médicale)	· Antécédents d'épilepsie ou de convulsions · Maladie chronique grave incluant le diabète insulinodépendant, toute cardiopathie ischémique ou un antécédent d'accident vasculaire cérébral, une immunodéficience. · Antécédent de thrombo-embolie veineuse. · Antécédent récent de cancer (traitement en cours ou fin depuis moins de 1 an) · Prise d'anti-dépresseurs
Effets secondaires courants	· Digestif: nausées, vomissements, diarrhée associée à des douleurs abdominales; · Parmi les effets indésirables potentiellement dangereux associés au traitement, on compte l'oedème angioneurotique et l'ictère cholestatique qui se sont produits chez moins de 1 % des patients.Parmi les effets indésirables potentiellement dangereux associés au traitement, on compte l'oedème angioneurotique , l'ictère cholestatique, la colite pseudomembraneuse et la pancréatite qui se sont produits chez moins de 1 % des patients.

Annexe 9 Contre-indications à l'acétazolamide (Diamox)

Contre-indications habituelles	· Hypersensibilité ou allergie à l'acétazolamide · Hypersensibilité à l'une des composantes du médicament · Glaucome chronique · Grossesse et allaitement · Insuffisance hépatique et rénale · Insuffisance surrénalienne · Prise de médications telles que les Amphétamines; les Béta-bloqueurs; les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (eg, methazolamide); la Cyclosporine; les antagonistes de l'acide folique tels que le 5-AAS, les corticostéroïdes et la cholestyramine (Questran); les anti-épileptiques tels que la phénytoïne, la Primidone et le Topiramate (Topamax); le Lithium; la Quinidine; la méthénamine l'antiseptique urinaire; les salicylates; et le bicarbonate de soude.
Contre-indications spécifiques à cette ordonnance collective (puisque nécessitant une consultation médicale)	· Antécédents d'épilepsie ou de convulsions · Maladie chronique grave incluant le diabète insulinodépendant, toute cardiopathie ischémique ou un antécédent d'accident vasculaire cérébral, une immunodéficience. · Antécédent de thrombo-embolie veineuse. · Antécédent récent de cancer (traitement en cours ou fin depuis moins de 1 an), ou prise d'une médication induisant une immunosuppression. · Antécédent de Mal aigu des montagnes ou d'oedème pulmonaire en altitude. · Prise d'antidépresseurs
Effets secondaires courants	Les effets secondaires de l'acétazolamide incluent · paresthésies · polyurie · nausées · somnolence · impuissance · myopie. · modification du goût des boissons gazéifiées, y compris celui de la bière

Annexe 10 Auteurs

Rédigé par : Dominique Tessier, md, ccfp, fcfp, fistm

Directeur médical des cliniques du Groupe santé voyage

Révisé par

Martin Brizard, md
Certificate in Travel Health-TM
Directeur médical du Groupe Santé voyage